



CONSENTIMIENTO INFORMADO INTEGRADO PARA TERAPIAS (TERAPIA FISICA – TERAPIA RESPIRATORIA – FONOAUDIOLOGIA – TERAPIA OCUPACIONAL)

(EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 23 DE 1981, DE LA RESOLUCION 1995 DE 1999 Y DEMAS NORMAS RELACIONADAS
CON LA HISTORIA CLINICA)

Código: FT-HCR-18

Versión: 01

Fecha de actualización: junio 2025

Fecha de diligenciamiento DIA: _____ MES: _____ AÑO: _____ SERVICIO _____

Paciente:							
	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres	Edad	Documento	Domicilio	Teléfono
Personal de Salud Responsable del Procedimiento							
	Primer Apellido		Segundo Apellido		Nombres		

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO POR LA TOTALIDAD DEL TRATAMIENTO

Yo, _____, con numero de documento de identidad, _____ certifico que: He leído (o que se me han leído) el documento sobre Consentimiento Informado de **Terapia Física (Fisioterapia)** _____ **Terapia Respiratoria** _____ **Terapia del Lenguaje (Fonoaudiología)** _____ **Terapia Ocupacional** _____, que contiene información sobre los procedimientos y actividades encaminadas a mejorar la salud y calidad de vida del paciente.

LA FISIOTERAPIA es una terapia física que se le realiza al paciente para evaluar, impedir, corregir, aliviar y limitar o disminuir la incapacidad física, alteración del movimiento, funcionalidad y postura, así como el dolor que se deriven de los desórdenes, congénitos y de las condiciones del envejecimiento, lesión o enfermedad (daño o procedimiento quirúrgico).

LA FONOAUDIOLOGÍA (TERAPIA DEL LENGUAJE) es el tratamiento en casa que consiste en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de trastornos de la comunicación, el habla, el lenguaje, la voz y la deglución.

LA TERAPIA RESPIRATORIA es el procedimiento que consiste en una serie de técnicas y cuidados especializados destinados a mantener la vía aérea permeable, mejorar la ventilación y prevenir complicaciones respiratorias. Este procedimiento incluye la limpieza y mantenimiento de la cánula de traqueostomía, la aspiración de secreciones, la administración de oxígeno y la realización de ejercicios respiratorios.

La TERAPIA OCUPACIONAL es el tratamiento en casa que consiste en la evaluación y tratamiento de las habilidades necesarias para realizar actividades de la vida diaria (AVD). El objetivo es mejorar la independencia y calidad de vida del paciente mediante la rehabilitación de funciones motoras, cognitivas y sensoriales. El terapeuta ocupacional trabaja con el paciente y sus cuidadores para desarrollar un plan de tratamiento personalizado que puede incluir ejercicios, adaptaciones del entorno y el uso de dispositivos de asistencia.

SEGÚN TIPO DE TERAPIA, DILIGENCIE LOS SIGUIENTES CAMPOS:

Procedimientos para Terapia Física (Fisioterapia):

Según la condición clínica durante el tratamiento se pueden requerir de diferentes procedimientos como: movimientos activos o pasivos a través de procedimientos manuales por medio de la aplicación de técnicas y modelos terapéuticos; utilización terapéutica e higiénica de medios externos; aparatos mecánicos destinados a provocar y dirigir movimientos corporales regulados en su fuerza, trayectoria y amplitud, también por medio de aparatos eléctricos o de radiaciones electromagnéticas sobre el organismo, entre otros. Se puede requerir según mi condición clínica de procedimientos de diferente naturaleza, como son:

PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN	RIESGOS Y/O REACCIONES ADVERSAS	BENEFICIOS	IMPLICACIONES/ CONSECUENCIAS	POSIBLES ALTERNATIVAS	FIRMA PACIENTE O REPRESENTANTE
Evaluación fisioterapéutica	Valoración inicial del estado funcional del paciente mediante pruebas físicas, entrevistas y observación clínica.	Molestias leves durante la exploración, fatiga o dolor temporal.	Diagnóstico funcional preciso, base para plan de tratamiento personalizado.	Necesidad de colaboración activa del paciente.	Alternativas: Evaluación médica general o por otro profesional de la salud.	
Aplicación de medios físicos (calor, frío, electroestimulación)	Uso de agentes físicos para aliviar el dolor, reducir inflamación o estimular tejidos.	Quemaduras, irritación cutánea, reacciones alérgicas, molestias eléctricas.	Disminución del dolor, relajación muscular, mejora de la circulación.	Requiere supervisión profesional y sesiones repetidas.	Medicación analgésica, técnicas manuales.	
Ejercicios	Actividades físicas dirigidas a	Fatiga, mareo, dolor muscular,	Mejora del estado físico general, control	Necesidad de constancia y	Actividad física autónoma	

CONSENTIMIENTO INFORMADO INTEGRADO PARA TERAPIAS (TERAPIA FISICA – TERAPIA RESPIRATORIA – FONOAUDIOLOGIA – TERAPIA OCUPACIONAL)

(EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 23 DE 1981, DE LA RESOLUCION 1995 DE 1999 Y DEMAS NORMAS RELACIONADAS CON LA HISTORIA CLINICA)

Código: FT-HCR-18

Versión: 01

Fecha de actualización: junio 2025

cardiovasculares	mejorar la capacidad aeróbica y resistencia	riesgo cardiovascular en pacientes con patologías previas	del peso, salud cardiovascular.	monitoreo.	bajo indicaciones médicas.	
Propiocepción	Ejercicios para mejorar la percepción corporal y la coordinación neuromuscular.	Pérdida momentánea del equilibrio, caídas leves.	Prevención de lesiones, mejora del control motor.	Requiere concentración y práctica progresiva.	Terapias ocupacionales o entrenamiento funcional.	
Fuerza	Ejercicios para aumentar la capacidad muscular.	Dolor muscular, sobrecarga, lesiones si no se realiza adecuadamente.	Mejora de la funcionalidad, prevención de atrofia muscular.	Necesidad de progresión gradual y supervisión.	Entrenamiento físico independiente con asesoría.	
Equilibrio	Actividades para mejorar la estabilidad postural y prevenir caídas	Caídas leves, mareo.	Mayor seguridad al caminar, prevención de accidentes	Requiere práctica constante.	Terapias de integración sensorial o entrenamiento vestibular.	
Flexibilidad	Ejercicios de estiramiento para mejorar el rango de movimiento articular.	Dolor leve, distensión muscular si se realiza incorrectamente.	Mejora de la movilidad, reducción de rigidez.	Necesidad de continuidad y técnica adecuada.	Yoga, pilates, terapia manual.	
Otro procedimiento: describir y llenar los campos:						

Procedimientos para Terapia del Lenguaje (Fonoaudiología): para la evaluación, diagnóstico y tratamiento de trastornos de la comunicación, el habla, el lenguaje, la voz y la deglución.

PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN	RIESGOS Y/O REACCIONES ADVERSAS	BENEFICIOS	IMPLICACIONES/ CONSECUENCIAS	POSIBLES ALTERNATIVAS	FIRMA PACIENTE O REPRESENTANTE
Evaluación Fonoaudiología	Valoración integral de las funciones comunicativas, del habla, lenguaje, voz y deglución mediante entrevistas, pruebas estandarizadas y observación clínica.	Fatiga, frustración emocional, incomodidad durante pruebas específicas.	Identificación precisa de dificultades, base para diagnóstico y tratamiento.	Requiere colaboración activa del paciente y/o familia.	Evaluación por otros profesionales del área de la salud o educación.	
Trastornos De La Comunicación	Intervención para mejorar habilidades comunicativas en personas con dificultades para comprender o expresar ideas, ya sea verbal o no verbalmente.	Frustración, lentitud en el progreso, desmotivación.	Mejora en la interacción social, autonomía y calidad de vida.	Requiere compromiso, asistencia regular y apoyo familiar.	Terapias ocupacionales, programas educativos especializados.	
Trastornos Del Habla	Tratamiento de alteraciones en la articulación, fluidez o voz que afectan la producción del habla.	Cansancio vocal, frustración, progreso gradual.	Claridad en la expresión oral, mejora en la autoestima y comunicación.	Necesidad de práctica constante y seguimiento terapéutico.	Terapias complementarias, intervención psicológica si hay impacto emocional.	
Dificultades En El Lenguaje	Intervención para mejorar la comprensión y expresión del lenguaje oral y/o escrito.	Frustración, resistencia al cambio, progreso lento.	Mejora en el rendimiento académico, habilidades sociales y cognitivas.	Requiere continuidad, apoyo escolar y familiar.	Apoyo pedagógico, programas de estimulación temprana.	
Problemas En La Voz	Tratamiento de alteraciones en la calidad, intensidad o tono de la voz, como disfonías o afonías.	Fatiga vocal, recaídas si no se siguen indicaciones.	Mejora en la calidad vocal, prevención de daños mayores.	Requiere cambios en hábitos vocales y seguimiento terapéutico.	Evaluación otorrinolaringológica, tratamiento médico.	
Trastornos En La Deglución	Intervención para mejorar la seguridad y eficacia al tragar alimentos, líquidos o saliva.	Riesgo de aspiración si no se siguen indicaciones, fatiga durante ejercicios.	Prevención de complicaciones respiratorias, mejora en la nutrición y calidad de vida.	Requiere adaptación de la dieta, seguimiento médico y familiar.	Nutrición enteral, intervención médica especializada.	

Procedimientos para Terapia Respiratoria: encaminado a mejorar el intercambio gaseoso en el organismo:

PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN	RIESGOS Y/O REACCIONES ADVERSAS	BENEFICIOS	IMPLICACIONES/ CONSECUENCIAS	POSIBLES ALTERNATIVAS	FIRMA PACIENTE O REPRESENTANTE
Aspiración de secreciones	Procedimiento para eliminar secreciones acumuladas en las vías respiratorias mediante la	Ahogo Laceración de la mucosa Sangrado	Mantiene las vías respiratorias despejadas, previene infecciones y mejora la ventilación.	Complicaciones: Aunque los riesgos de la terapia respiratoria son mínimos,	Hospitalización: En lugar de recibir terapia respiratoria en casa, el paciente puede ser	

CONSENTIMIENTO INFORMADO INTEGRADO PARA TERAPIAS (TERAPIA FISICA – TERAPIA RESPIRATORIA – FONOAUDIOLOGIA – TERAPIA OCUPACIONAL)

(EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 23 DE 1981, DE LA RESOLUCION 1995 DE 1999 Y DEMAS NORMAS RELACIONADAS CON LA HISTORIA CLINICA)

Código: FT-HCR-18

Versión: 01

Fecha de actualización: junio 2025

	aspiración con un catéter. Es esencial para pacientes con traqueostomía o aquellos que no pueden expectorar adecuadamente.		Permeabilización de la vía aérea. Permite la higiene bronquial. Favorece la oxigenación. Reduce el riesgo de infección.		hospitalizado para recibir cuidados respiratorios intensivos. Aunque esto puede ofrecer un monitoreo más cercano, también puede ser más costoso y menos conveniente para el paciente y su familia.	
Nebulización y Terapia Inhalatoria (administración de oxígeno)	Administración de medicamentos en forma de aerosol para tratar afecciones respiratorias como el asma, la EPOC y las infecciones pulmonares. Los medicamentos pueden incluir broncodilatadores, corticosteroides y antibióticos.	Nauseas Sensación de sofocamiento por las mascarar Sequedad en las mucosas Sangrado nasal Pulso rápido	Facilita la entrega directa de medicamentos a los pulmones, mejorando la eficacia del tratamiento y reduciendo los efectos secundarios sistémicos. Disminuir producción de secreciones. Bronco dilatar vía aérea. Desinflamar vía aérea Mejorar la saturación de oxígeno. Disminuir la disnea. Disminuir episodios de tos.	pueden incluir reacciones alérgicas a los medicamentos inhalados, infecciones, y complicaciones relacionadas con la manipulación de la cánula. Es importante monitorear al paciente de cerca y seguir los protocolos de seguridad para minimizar estos riesgos. Requerimientos de Cuidado Continuo: La terapia respiratoria en casa requiere un compromiso continuo por parte del paciente y sus cuidadores para realizar los cuidados diarios y seguir las indicaciones del terapeuta respiratorio. Esto puede implicar una carga adicional para los cuidadores, pero es esencial para el éxito del tratamiento.	Rehabilitación en Centros Especializados: El paciente puede asistir a centros de rehabilitación especializados en terapia respiratoria. Estos centros ofrecen equipos y personal especializado, pero pueden requerir desplazamientos frecuentes y pueden no ser tan cómodos como recibir tratamiento en casa.	
Maniobras de higiene bronquial	Maniobras sobre el tórax de manera manual o con aparatos para extraer secreciones.	Dolor Intolerancia al ejercicio Hematomas Fracturas	Desprender secreciones bronquiales y movilizarlas Mejorar oxigenación. Higiene bronquial. Reducir el riesgo de infección.		desplazamientos frecuentes y pueden no ser tan cómodos como recibir tratamiento en casa.	
Ejercicios de Rehabilitación Pulmonar	Programas de ejercicios diseñados para mejorar la capacidad pulmonar, la fuerza muscular respiratoria y la tolerancia al ejercicio. Incluyen técnicas de respiración, ejercicios aeróbicos y entrenamiento de fuerza.	Disnea Dolor Intolerancia a la actividad Hematomas Fracturas costales	Mejora la función pulmonar, reduce la disnea y aumenta la capacidad de realizar actividades diarias. Control de patrón respiratorio. Mejorar volúmenes espiratorios e inspiratorios Fortalecimiento diafragmático.		Terapias Alternativas: Algunas terapias alternativas, como la fisioterapia respiratoria, pueden complementar o sustituir ciertos aspectos de la terapia respiratoria en casa. Estas terapias pueden ser útiles, pero es importante discutirlos con el médico para asegurar que sean adecuadas para la condición específica del paciente.	
Cuidados de la traqueostomía	Curación del estoma traqueal y aspiración de secreciones traqueales por medio de sondas estériles.	Nauseas Sensación de ahogo Sangrado Salida de cánula de traqueostomía. Infección	Evitar infecciones. Permeabilizar vía aérea Mejorar la oxigenación.		Entiendo que tengo el derecho de rehusar parte o todo el tratamiento en cualquier momento.	
Manejo de la Traqueostomía	Cuidados específicos para pacientes con traqueostomía, incluyendo la limpieza y el cambio de la cánula, la aspiración de secreciones y la prevención de infecciones.	Obstrucción de la Vía Aérea Desplazamiento o Desalojo de la Cánula Lesiones en la Piel y Tejidos Hemorragias Fístulas Traqueoesofágicas Aspiración de Secreciones Deshidratación y Desequilibrio Electrolítico Ansiedad y Estrés	Asegura la permeabilidad de la vía aérea y previene complicaciones asociadas con la traqueostomía.			
Educación y Apoyo al Paciente y Familiares	Proporcionar información y entrenamiento a los pacientes y sus cuidadores sobre el manejo de la enfermedad respiratoria, el uso de equipos y la realización de ejercicios respiratorios.	No aplica	Empodera a los pacientes y sus familias, mejorando la adherencia al tratamiento y la calidad de vida.			
Otro procedimiento: describir y llenar los campos:						

CONSENTIMIENTO INFORMADO INTEGRADO PARA TERAPIAS (TERAPIA FISICA – TERAPIA RESPIRATORIA – FONOAUDIOLOGIA – TERAPIA OCUPACIONAL)

(EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 23 DE 1981, DE LA RESOLUCION 1995 DE 1999 Y DEMAS NORMAS RELACIONADAS CON LA HISTORIA CLINICA)

Código: FT-HCR-18

Versión: 01

Fecha de actualización: junio 2025

Procedimientos para Terapia Ocupacional: para la evaluación y tratamiento de las habilidades necesarias para realizar actividades de la vida diaria (AVD), puede incluir ejercicios, adaptaciones del entorno y el uso de dispositivos de asistencia:

PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN	RIESGOS Y/O REACCIONES ADVERSAS	BENEFICIOS	IMPLICACIONES/ CONSECUENCIAS	POSIBLES ALTERNATIVAS	FIRMA PACIENTE O REPRESENTANTE
Evaluación en Terapia Ocupacional	Valoración integral del desempeño ocupacional mediante entrevistas, observación y pruebas estandarizadas.	Fatiga, frustración emocional, incomodidad durante la evaluación.	Identificación precisa de dificultades y fortalezas para diseñar un plan de intervención.	Requiere colaboración activa del paciente y/o familia.	Evaluación por otros profesionales de la salud o educación.	
Trastornos de la Motricidad Fina	Intervención para mejorar habilidades manuales como agarre, coordinación y precisión.	Cansancio, frustración, progreso lento.	Mejora en la autonomía y desempeño en actividades escolares o cotidianas.	Requiere práctica constante y seguimiento terapéutico.	Apoyo pedagógico, terapia física.	
Trastornos de la Motricidad Gruesa	Ejercicios y actividades para mejorar el control postural, equilibrio y coordinación general.	Caídas leves, fatiga, frustración.	Mejora en la movilidad, participación en juegos y actividades físicas.	Necesidad de continuidad y supervisión.	Terapia física, programas deportivos adaptados.	
Alteraciones en las Actividades de la Vida Diaria (AVD)	Entrenamiento en habilidades como vestirse, alimentarse, higiene personal, entre otras.	Frustración, resistencia al cambio.	Mayor independencia y calidad de vida.	Requiere compromiso del paciente y apoyo familiar.	Apoyo de cuidadores, intervención educativa.	
Trastornos Sensoriales	Terapia de integración sensorial para modular respuestas a estímulos del entorno.	Sobrecarga sensorial, incomodidad, desregulación emocional.	Mejora en la autorregulación, atención y participación.	Requiere sesiones regulares y adaptación del entorno.	Terapia psicológica, intervención educativa.	
Rehabilitación Funcional	Intervención para recuperar habilidades perdidas por lesión o enfermedad.	Dolor, fatiga, frustración ante el progreso lento.	Recuperación de la funcionalidad y autonomía.	Requiere compromiso, asistencia regular y seguimiento médico.	Terapia física, apoyo familiar o institucional.	
Otro procedimiento: describir y llenar los campos:						

APRECIADO USUARIO CALIFIQUE EN UNA ESCALA DE 1, 3 O 5 EL NIVEL ENTENDIMIENTO REFERENTE AL CONSENTIMIENTO INFORMADO:

ESCALA: 1. No comprendido. 3. Medianamente comprendido. 5. Comprendido completamente.

Coloque aquí su calificación en: _____ -

ENTIENDO MI PLAN DE TRATAMIENTO Y CONSIENTO - ACEPTO -EN SER TRATADO POR UN PROFESIONAL DE APOYO TERAPÉUTICO

HUELLA PACIENTE		
	Firma del Paciente	Cedula del Paciente
	Firma y Cedula del acudiente o testigo	Firma y sello o registro del personal de la salud

**CONSENTIMIENTO INFORMADO INTEGRADO PARA TERAPIAS
(TERAPIA FISICA – TERAPIA RESPIRATORIA – FONOAUDIOLOGIA –
TERAPIA OCUPACIONAL)**

(EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 23 DE 1981, DE LA RESOLUCION 1995 DE 1999 Y DEMAS NORMAS RELACIONADAS
CON LA HISTORIA CLINICA)

Código: FT-HCR-18

Versión: 01

Fecha de actualización: junio 2025

NO CONSENTIMIENTO

Con pleno conocimiento de los riesgos y después de haber sido informado, he decidido **no aceptar** la realización de la terapia y/o procedimiento, haciéndome responsable de las consecuencias que se puedan derivar de esta decisión.

HUELLA PACIENTE		
	Firma y cedula del Paciente	Firma y cedula del acudiente o testigo
	Firma y sello o registro del personal de la salud	